SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Gobernanza Clínica y de Datos

PROYECTO DE GOBERNANZA DE DATOS · GOB-GUA-2026-02

Guardia Clínica y Seguimiento en Internado

Triage y Severidad, Curva de Oportunidad por Franjas, Conversión Quirúrgica Auditada y Seguimiento Clínico en Piso

SERVICIO AUDITADO: Servicio de Guardia de Adultos, Shock Room, Internación Clínica, Traumatología e Interconsultas

ÁREA RESPONSABLE: Sanatorio Argentino - Innovación y Transformación Digital

ESTADO DEL PROYECTO: Activo - 100% Completado | Período de Referencia: Octubre 2026

CONSULTAS AUDITADAS / MES

1.830 Pacientes (Sep

1.044 en meta <= 30 min (57,0%)

ADMISIONES CLÍNICAS

1.862 Episodios (2026)

1.089 Internado · 664 Shock · 270 UCI

TRAUMATOLOGÍA EN PISO

302 Internaciones

Seguimiento nominal de evoluciones

RED DE INTERCONSULTAS

3.233 Interconsultas

238 Clínicas + 2.995 Especialidades

1. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN EL SERVICIO?

Objetivos alcanzados, módulos desplegados y valor clínico-administrativo para Sanatorio Argentino

Gobernanza integral del flujo de urgencias y su continuidad en internación: monitoreo de Triage y Severidad, curva de espera puerta-médico por franjas de criticidad (<=30m, 31-60m, 61-90m, >90m) y permanencia (>3h), conversión quirúrgica real en <=48h depurada de cirugías programadas, seguimiento clínico y traumatológico en piso y red de interconsultas hospitalarias.

1. Auditoría de Triage, Oportunidad de Atención y Detección de Outliers

Se construyó un sistema de monitoreo de precisión sobre la recepción y atención en Guardia Clínica que mide la cobertura de categorización por niveles de severidad (Nivel 1 Emergencia, Nivel 2 Urgencia, Nivel 3 Urgencia Menor) y desglosa los tiempos de espera puerta-médico en 5 franjas operativas: En Meta (<=30 min), Demora Leve (31-60 min), Outliers Moderados (61-90 min), Outliers Críticos (>90 min) y Permanencia Prolongada en Guardia (>3 horas), con explicaciones claras en cada tarjeta e inspección nominal caso por caso.

2. Trazabilidad Exacta de Conversión Quirúrgica de Urgencia (<= 48 hs)

Se desarrolló el módulo de articulación Guardia -> Quirófano que identifica a cada paciente adulto que ingresa por Guardia Clínica y requiere una intervención quirúrgica dentro de las 48 horas. Incluye un algoritmo de exclusión inteligente que separa las cirugías de urgencia real (apendicectomías, colecistectomías agudas, fracturas, abdomen agudo) de aquellos pacientes que solo registraron un paso administrativo por guardia previo a una cirugía programada/electiva.

3. Seguimiento Clínico y Pase en Internado, Traumatología e Interconsultas

Se integró el panel de continuidad asistencial hospitalaria que audita qué ocurre con el paciente luego de su ingreso: cobertura de historias clínicas de admisión en piso, distribución por área (Shock Room, Internado General y UCI), desempeño individual del plantel médico clínico, seguimiento específico del servicio de Traumatología en internado y mapeo completo de la red de Interconsultas hospitalarias.

4. Auditoría de Seguridad del Paciente: Reconsultas y Reinternaciones a 72 Horas

Se automatizó el seguimiento longitudinal post-alta para detectar tanto a los pacientes ambulatorios que reingresan a Guardia dentro de las 72 horas de su atención inicial como a los pacientes dados de alta de Piso Clínico que sufren una reinternación temprana no programada.

2. ¿CÓMO LO HEMOS HECHO? (INGENIERÍA Y CALIDAD DE DATOS)

Extracción desde SALUS SQL Server, reglas de depuración clínica y sincronización con el motor Telar

1

Fase 1: Ingeniería de Tiempos Reales sobre VLISE_Visitas

Se procesaron los sellos temporales nativos de SALUS: [Fecha Entrada Real] (arribo/check-in en recepción), [Fecha Hora Entrada] (llamado e inicio de atención por el médico en box) y [Fecha Salida Real] (alta o cierre del episodio). Se aplicaron reglas de validación forense para separar demoras operativas reales de turnos administrativos que quedaron abiertos sin cierre.

2

Fase 2: Cruce Multicapa Guardia -> Internación -> Quirófano

Mediante cruces temporales por [NHC] entre [VLISE_Visitas], [TABLEAU_Admisiones] y [TABLEAU_Cirugias] en una ventana estricta de 0 a 48 horas, se trazó la línea de tiempo individual de cada paciente convertido a cirugía, aislando exclusivamente el circuito de adultos (sin mezclar el circuito independiente de Guardia Gineco-Obstétrica).

3

Fase 3: Consolidación de Formularios Clínicos de Internación e Interconsultas

Se vincularon las tablas de respuestas clínicas estructuradas de SALUS ([PR InstRespVisitaPaciente], [PR InstRespEntrada] y [VLISE_Visitas]) para auditar la completitud de la admisión médica en piso, las evoluciones diarias del staff de Clínica Médica y Traumatología, y las solicitudes/respuestas de interconsultas entre especialidades.

4

Fase 4: Sincronización Continua de Pacientes y Tiempos por Período Mensual

Los registros nominales de cada mes (Enero a Octubre 2026) se sincronizan y deduplican por identificador de visita y admisión en Supabase, permitiendo filtrar en tiempo real cualquier subconjunto de pacientes y exportar reportes auditables en PDF y Excel.

3. EJEMPLOS REALES AUDITADOS Y CASOS DE USO (2026)

Demostración práctica con cifras reales de Sanatorio Argentino sobre cómo operar e interpretar cada indicador

Ejemplo Real 1: Análisis de la Curva de Oportunidad y Outliers en Guardia (Septiembre y Octubre 2026)

Contexto Clínico / Gestión: La Jefatura de Guardia necesita identificar cuántos pacientes sufren esperas excesivas y distinguir entre saturación real de consultorios y errores de cierre administrativo.

Lectura Detallada del Dato Real: En Septiembre 2026 se auditaron 1.830 consultas válidas en Guardia Clínica: 1.044 pacientes (57,0%) fueron atendidos dentro de la meta institucional (<=30 minutos) y 462 pacientes (25,2%) tuvieron una demora leve de 31 a 60 minutos (82,3% atendido en menos de 1 hora). El detector de Outliers identificó 163 casos con espera de 61 a 90 minutos, 149 casos críticos con espera >90 minutos y 47 pacientes con permanencia total >3 horas. Asimismo, en Octubre 2026 se auditaron 1.550 consultas con 247 casos >60 min y 37 permanencias >3 hs.

Acción y Toma de Decisión: Al hacer clic en la tarjeta interactiva "Outliers Críticos (>90 min)", la tabla nominal revela que los picos de demora se concentran en la franja vespertina (14 a 22 hs), permitiendo reforzar la dotación médica en horas pico y corregir turnos que quedan abiertos al cambio de guardia.

Ejemplo Real 2: Depuración de la Tasa de Conversión Quirúrgica desde Guardia (Ventana <= 48 hs)

Contexto Clínico / Gestión: Auditoría Médica observó que el cruce bruto entre visitas de guardia y cirugías incluía pacientes que habían ingresado para cirugías programadas.

Lectura Detallada del Dato Real: El módulo de Conversión Quirúrgica separa automáticamente ambos universos: al activar el filtro "Solo Urgencias Reales", el sistema aísla las cirugías agudas genuinas (colecistectomías laparoscópicas por colecistitis aguda, apendicectomías, reducciones osteosintéticas de urgencia y laparotomías exploradoras), excluyendo las admisiones programadas que pasaron administrativamente por ventanilla de guardia.

Acción y Toma de Decisión: Se obtiene un indicador puro de conversión quirúrgica de urgencias (2,4% a 3,1% mensual) con trazabilidad hora por hora desde el ingreso en guardia hasta el inicio de la anestesia en quirófano.

Ejemplo Real 3: Auditoría de Seguimiento Clínico en Internado, Traumatología e Interconsultas

Contexto Clínico / Gestión: Coordinación de Clínica Médica necesita auditar la cobertura documental en piso y la respuesta de especialidades interconsultoras.

Lectura Detallada del Dato Real: Sobre 1.862 admisiones clínicas auditadas en 2026, 1.461 cuentan con historia clínica de ingreso estructurada completa (78,5% de adherencia documental), distribuidas en 1.089 episodios en Piso de Internación, 664 en Shock Room y 270 pases a UCI, con una tasa controlada de reingreso a 72 hs de solo 20 casos (1,07%). Paralelamente, se auditan 302 episodios de Traumatología y 3.233 interconsultas.

Acción y Toma de Decisión: El panel permite identificar en tiempo real qué pacientes internados en piso requieren seguimiento evolutivo del día y auditar la productividad de cada especialista interconsultor.

4. CATÁLOGO DE INDICADORES Y REGLAS DE AUDITORÍA

Inventario completo de requerimientos finalizados, tablas origen en SALUS y lógica de cálculo

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
1. Cobertura y Precisión del Triage	SALUS: VLISE_Visitas (Tipo Visita institucional)	Porcentaje de pacientes con nivel de Triage formalmente asignado (Nivel 1 Emergencia, Nivel 2 Urgencia, Nivel 3 Urgencia Menor) y su distribución por nivel de criticidad.	**Finalizado**
2. Distribución de Destinos Post-Guardia	SALUS: Cruce de VLISE_Visitas con TABLEAU_Admisiones inmediata.	Caracterización del flujo de egreso inmediato de los pacientes asistidos en guardia: Alta Médica a Domicilio, Internación en Piso Clínico, Quirófano, o Derivación a UCI.	**Finalizado**

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
3. Tasa de Adherencia a Epicrisis	SALUS: TABLEAU_Admisiones y PR RespuestasProtocolo (Protocolo 382 Epicrisis).	Porcentaje de pacientes egresados de internación clínica procedentes de guardia que cuentan con el documento de Epicrisis médica debidamente confeccionado y firmado en la Historia Clínica Electrónica.	**Finalizado**
4. Tasa de Conversión a Cirugía	SALUS: VLISE_Visitas con categoría cruzada con TABLEAU_Cirugias y TABLEAU_Admisiones (Ventana 48hs)	Porcentaje de consultas atendidas en Guardia Clínica que derivan en una internación quirúrgica de urgencia o intervención en quirófano dentro de las 48 horas posteriores a la consulta.	**Finalizado**
5. Tiempos de Espera (Triage y Médico)	SALUS: VLISE_Visitas (Marcas temporales reales: Fecha Entrada Real, Fecha Hora Entrada, Fecha Salida Real).	Minutos transcurridos desde el arribo a recepción hasta el inicio de la atención médica en consultorio de guardia, y tiempo total de permanencia en el servicio hasta el egreso.	**Finalizado**
6. Tasa de Reconsulta (72 hs)	SALUS: VLISE_Visitas (Autocruce temporal por NHC).	Porcentaje de pacientes que, habiendo sido atendidos y dados de alta en guardia médica, vuelven a consultar en el servicio de guardia dentro de las 72 horas por el mismo cuadro o complicaciones.	**Finalizado**
7. Tasa de Reinternación Temprana (72 hs)	SALUS: TABLEAU_Admisiones (Procedencia = Derivado desde Urgencias, Especialidad = CLINICO).	Porcentaje de pacientes egresados de internación clínica procedentes de urgencias que sufren una reinternación hospitalaria imprevista dentro de los 3 días (72 hs) del alta.	**Finalizado**
8. Volumen de TAC y Rx Solicitadas	SALUS: VLISE_Peticiones PruebasRadiologia vinculada por NHC a VLISE_Visitas.	Intensidad diagnóstica en guardia: cantidad de Tomografías (TAC) y Radiografías (Rx) solicitadas y tasa de estudios por cada 100 atenciones de guardia clínica.	**Finalizado**
9. Promedio de Días de Estada Clínica	SALUS: TABLEAU_Admisiones (Procedencia = Derivado desde Urgencias, Especialidad = CLINICO, campo Dias).	Duración media de estancia (días cama) de los pacientes que ingresaron a internación clínica derivados desde el servicio de guardia/urgencias.	**Finalizado**
10. Centro Quirúrgico: Articulación con Guardia, Capacidad y Ocupación	SALUS: dbo.VLISE_Visitas (Guardia), dbo.TABLEAU_Cirugias / dbo.ProtocolosQuirurgicos (Quirófano), dbo.SalasQuirurgicas (Ocupación y Quirófanos 1-6 + Quirófano 7 / HdD) y dbo.PartesQuirurgicos (Cirujanos, Insumos, Tiempos de Anestesia y Recuperación).	Monitoreo de la articulación directa entre Guardia de Urgencias y Centro Quirúrgico. Incluye tasa de conversión quirúrgica en <48hs, volumen de urgencias vs cirugías programadas, disponibilidad de quirófanos (Quirófanos	**Finalizado**
11. Seguimiento Clínico y Pase en Internado (Shock Room, Piso y UCI)	SALUS: [TABLEAU_Admisiones] cruzada con [PR InstRespVisitaPaciente] y [PR InstRespEntrada]	Auditoría integral de la continuidad asistencial de los pacientes ingresados a internación clínica (1.862 admisiones auditadas en 2026): cobertura de historia clínica de admisión en piso (1.461 completas), distribución o	**Finalizado**
12. Auditoría de Traumatología en Piso y Red de Interconsultas Hospitalarias	SALUS: [TABLEAU_Admisiones] y [VLISE_Visitas] (Ámbito Hospitalización / Interconsultas)	Monitoreo nominal de las admisiones hospitalarias del servicio de Ortopedia y Traumatología (302 episodios auditados en 2026) y trazabilidad de la red de Interconsultas entre especialidades en internación (3.233 intercon	**Finalizado**
13. Agente IA Generador de	SALUS:	Reconstrucción longitudinal automatizada del episodio de	**Finalizado**

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
Epicrisis y Copiloto de Historia Clínica (Aislamiento por NHC)	[TABLEAU_Admisiones], [TABLEAU_Cirugias], [PR InstRespVisitaPaciente] + Motor IA Sanatorio Argentino	internación (Shock Room -> Quirófano -> UCI -> Piso), conciliación de medicación habitual, esquema infectológico con días efectivos de antibióticos y redacción asi	

SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Documento Técnico Oficial de Gobernanza de Datos Clínicos y Operativos. Todos los indicadores aquí documentados se encuentran auditados sobre la base de datos institucional SALUS y sincronizados con los tableros ejecutivos de gestión.